

항콜린제 (과민성 방광용)

환자 안내문 · 방광의 과도한 수축을 억제하는 약

WARWIKI

항콜린제(항무스카린제라고도 함)는 과민성 방광(OAB)을 조절하는 약으로, 갑작스러운 절박뇨, 빈뇨, 절박성 요실금을 줄여 줍니다. 대표적인 약으로는 **oxybutynin, tolterodine, solifenacin, fesoterodine, darifenacin, trospium**이 있으며, oxybutynin은 패치나 젤 형태로도 사용됩니다. 오랜 역사를 가진 효과적인 치료 옵션입니다.

작용 원리

방광 근육을 수축시키는 **신호를 차단**하여 방광이 소변이 차는 동안 덜 자주, 덜 갑작스럽게 수축하도록 합니다. 그 결과 절박뇨와 빈뇨가 줄어듭니다. 복용하는 동안 증상을 조절하며, 효과는 몇 주에 걸쳐 나타납니다.

기대 효과

- 효과는 보통 **수 주 후에** 나타납니다 — 판단하기 전에 충분히 기다리세요.
- 서방형의 경우 대부분 **하루 1회** 복용합니다.
- **서방형 알약, 패치, 젤**은 속효성 oxybutynin보다 입 마름 부작용이 적습니다.

용어 설명

과민성 방광(OAB)

방광이 너무 일찍 수축하여 나타나는 절박뇨와 빈뇨.

항콜린제 / 항무스카린제

방광 근육을 진정시키는 약물 분류.

입 마름

가장 흔한 부작용.

항콜린 부담

여러 항콜린 약물의 누적 효과 — 고령자에서 특히 중요.

베타-3 작용제

이러한 부작용이 적은 다른 OAB 약물(대안).

폐쇄각 녹내장

이 약의 사용을 보통 피해야 하는 눈 상태.

고령자를 위한 안내 고령자에서 이 약은 **기억력과 사고력**에 영향을 줄 수 있으며, 여러 항콜린제를 장기간 함께 복용하면 인지 기능 저하와 관련이 있다는 보고가 있습니다. 이 점이 걱정되신다면 해당 부작용이 없는 **베타-3 작용제**로 대체할 수 있으니 의 료진과 상담하세요.

복용 방법

- 지시대로 **하루 1회** 복용하고, 절박뇨가 완전히 가라앉지 않았다고 일찍 중 단하지 마세요.
- 입 마름이 심하면 **서방형 알약, 패치, 또는 젤**로 변경하는 것을 의료진과 상의하세요.
- 방광 훈련과 골반저근 운동을 병행하면 더 좋은 효과를 기대할 수 있습니 다.

주요 안전 정보

- 치료되지 않은 **폐쇄각 녹내장**이 있으면 보통 사용하지 않습니다 — 눈 질 환이 있으면 반드시 알려 주세요.
- **배뇨 장애**, 심한 변비, 특정 위장 질환이 있으면 주의가 필요합니다.
- 땀 분비를 줄일 수 있으므로 **더운 날씨**에는 과열에 주의하세요.

부작용

- **입 마름과 변비** (가장 흔함)
- 시야 흐림, 안구 건조
- 졸음; 고령자에서는 혼란

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- **소변이 전혀 나오지 않거나** 방광이 비워지지 않 는 느낌
- **새로운 혼란이나 기억력 저하**, 특히 고령자에서
- 심한 변비, 또는 **시야 흐림을 동반한 눈 통증·충 혈**

기억할 세 가지

1. 항콜린제는 과민성 방광을 조절하여 절박뇨, 빈 뇨, 절박성 요실금을 줄여 줍니다; 효과가 나타 나기까지 수 주가 걸립니다.
2. 입 마름과 변비가 흔하게 나타나며 — 서방형 알 약, 패치, 젤이 도움이 됩니다.
3. 고령자에서는 인지 기능에 영향을 줄 수 있으므 로 베타-3 작용제가 대안이 될 수 있습니다. 소 변이 나오지 않거나 새로운 혼란이 생기면 연락 하세요.